iltuofisiatra.it

Cognome	Nome
Diagnosi	
data di nascita	
data di ingresso	

NIH Stroke Scale - Versione italiana
Scala per l'ictus del National Institute of Health

Funzione da esaminare - Istruzioni	Punteggi	orario visita				
		8	12	16	20	24
1a. Livello di coscienza: vigilanza L'esaminatore deve scegliere una risposta anche se la valutazione è resa difficoltosa dalla presenza di tubi endotracheali, difficoltà linguistiche, traumi o medicazioni orotracheali. Il punteggio '3' viene attribuito solo se il paziente non fa alcun movimento (eccettuati i riflessi posturali) in risposta a stimolazioni nocicettive.	**0.** Vigile **1.** Soporoso, ma obbedisce, risponde o esegue in seguito a stimoli di modesta entità. **2.** Stuporoso, presta attenzione solo in seguito a stimolazioni ripetute, oppure compie movimenti (non stereotipati) in seguito a stimoli intensi o dolorosi. **3.** Gli stimoli suscitano solo risposte motorie riflesse o manifestazioni vegetative, oppure non c'è alcuna risposta.	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
1b. Livello di coscienza: orientamento Va chiesto al paziente prima in che mese siamo e poi la sua eta'. Le risposte devono essere precise: risposte parziali non vanno considerate valide. Se il paziente è afasico o stuporoso (1a='2') il punteggio è '2'. Se il paziente non può parlare perche' perchè intubato o per trauma orotracheale, disartria grave, difficoltà linguistiche o altro problema non secondario ad afasia, il punteggio è '1'.	**0.** Risponde correttamente ad entrambe le domande. **1.** Risponde correttamente ad una delle due domande. **2.** Non risponde correttamente a nessuna delle due domande.	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐
1c. Livello di coscienza: comprensione ed esecuzione di ordini semplici Va chiesto al paziente di aprire e chiudere gli occhi e poi di aprire e chiudere la mano non paretica. Se le mani non possono essere usate, l'ordine va sostituito con un altro comando semplice. L'ordina si considera correttamente eseguito anche se il paziente non riesce a portarlo a termine per ipostenia. Se il paziente non risponde al comando verbale, l'esaminatore può mimare il gesto e dare comunque un punteggio. Se il paziente ha esiti di trauma, amputazioni o altri impedimenti fisici vanno utilizzati ordini semplici adeguati. Viene valutato solo primo tentativo.	**0.** Esegue correttamente entrambi gli ordini. **1.** Esegue correttamente uno dei due ordini. **2.** Non esegue correttamente nessuno dei due ordini.	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐
2. Sguardo Si valutano solo i movimenti oculari orizzontali, volontari o riflessi (oculocefalici), ma senza ricorso al test calorico. Se il paziente ha una deviazione coniugata dello sguardo che può essere superata dall'attività volontaria o riflessa, il punteggio è '1'. In caso di paralisi periferica isolata (III, IV o VI nervo cranico) il punteggio è '1'. Lo sguardo è valutabile anche negli afasici. In caso di trauma oculare, bende, cecità o altri disturbi visivi preesistenti, verrà valutata la motilità riflessa e il punteggio verrà attribuito a discrezione dell'esaminatore. Stabilire un contatto visivo col paziente e poi muoversi attorno a lui può a volte servire a svelare la presenza di una paralisi parziale dello sguardo.	**0.** Normale. **1.** Paralisi parziale dello sguardo orizzontale. Lo sguardo è anormale in uno od entrambi gli occhi, ma non c'è paralisi totale o deviazione forzata. **2.** Deviazione forzata dello sguardo, o paralisi totale. La manovra oculocefalica non riesce a spostare gli occhi oltre la linea mediana.	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐
3. Campo visivo Il campo visivo (quadranti superiori ed inferiori) viene valutato per confronto o con la tecnica della minaccia visiva, a seconda della situazione. Il movimento laterale dello sguardo verso le dita in movimento è considerato indice di normalità del campo visivo da quel lato. In presenza di cecità mono-oculare, si valuta il campo visivo dell'occhio sano. Il punteggio '1' va attribuito solo in caso di chiara asimmetria. In presenza di cecità bilaterale, qualsiasi ne sia l'origine, il punteggio è '3'. Il test va concluso con la stimolazione simultanea bilaterale. Se c'è estinzione il punteggio è '1' e il risultato viene utilizzato per rispondere alla domanda 11 (inattenzione).	**0.** Normale. Assenza di deficit campimetrici. **1.** Emianopsia parziale (quadrantopsia). **2.** Emianopsia completa. **3.** Emianopsia bilaterale (include la cecità bilaterale di qualunque causa).	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
4. Paralisi facciale Va chiesto al paziente di mostrare i denti, alzare le sopracciglia e chiudere gli occhi. Le richieste possono essere mimate. In caso di afasia o scarsa collaborazione, va valutata la simmetria dei movimenti del volto in risposta agli stimoli dolorosi. Se il paziente ha esiti di trauma, bende, tubo orotracheale, cerotti o altre ostacoli fisici all'esame completo della faccia, questi dovrebbero essere rimossi per quanto possibile.	**0.** Assente. Movimenti facciali simmetrici. **1.** Paresi lieve. Spianamento del solco naso-labiale. Asimmetria del sorriso. **2.** Paresi parziale. Ipostenia totale o subtotale della metà inferiore della faccia. **3.** Paralisi completa mono- o bilaterale. Assenza di movimenti della metà superiore ed inferiore della faccia.	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

		8	12	16	20	24
5a. Motilità dell'arto superiore sinistro L'arto superiore va posizionato dall'esaminatore con le palme verso il basso, a 90° se il paziente è seduto o a 45° se è supino. Il paziente deve mantenere la posizione per 10 secondi. Se è afasico viene incoraggiato usando un tono imperioso e la mimica, ma non con stimoli dolorosi. Gli arti si esaminano uno alla volta, iniziando dal lato non paretico. In caso di amputazione o di anchilosi si assegna il punteggio 'NV' (non valutabile). Occorre comunque fornire spiegazione scritta del perché di tale punteggio.	**0.** Nessuno slivellamento per 10" **1.** Slivellamento (senza caduta) prima che siano trascorsi 10" **2.** Caduta prima di 10" **3.** Presenza di movimento a gravità eliminata **4.** Nessun movimento **NV.** Amputazione o anchilosi (spiegare)	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐
5b. Motilità dell'arto superiore destro idem come sopra	idem come sopra	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐
6a. Motilità dell'arto inferiore sinistro L'arto inferiore va esaminato sollevandolo con un angolo di 30° a paziente supino. Il paziente deve mantenere la posizione per 5 secondi. Il paziente afasico viene incoraggiato usando un tono imperioso e la mimica, ma non con stimoli dolorosi. Gli arti si esaminano uno alla volta, iniziando dal lato non paretico. In caso di amputazione o di anchilosi si assegna il punteggio 'NV' (non valutabile). Occorre comunque fornire spiegazione scritta del perché di tale punteggio.	**0.** Nessuno slivellamento per 5" **1.** Slivellamento (senza caduta) prima che siano trascorsi 5" **2.** Caduta prima di 5" **3.** Presenza di movimento a gravità eliminata **4.** Nessun movimento **NV.** Amputazione o anchilosi (spiegare)	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐
6b. Motilità dell'arto inferiore destro idem come sopra	idem come sopra	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ NV ☐
7. Atassia degli arti Questa prova è finalizzata al rilevamento di un disturbo di circolo posteriore. Deve essere eseguita con il paziente ad occhi aperti, in caso di deficit del campo visivo assicurarsi che la prova avvenga nella parte non compromessa. La prova indice-naso e calcagno-ginocchio viene eseguita su entrambi i lati, e la asimmetria è considerata presente solo in assenza di deficit di forza. L'atassia è considerata assente in caso di plegia o paresi grave, o se il paziente non collabora. Il punteggio 'NV' sarà assegnato solo in caso di amputazione o anchilosi dell'arto, fornendo spiegazione scritta.	**0.** Assente **1.** Presente o all'arto superiore o all'inferiore **2.** Presente sia all'arto superiore che all'arto inferiore. **NV.** Amputazione o anchilosi (spiegare)	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐
8. Sensibilità Si stima valutando la risposta del paziente alla puntura di spillo su tutte le sezioni corporee (braccia [non mani], gambe, tronco, viso). Il punteggio '2' dovrebbe essere assegnato solo quando puo' essere chiaramente dimostrata una perdita sensoriale grave o totale.	**0.** Normale **1.** Ipoestesia lieve o moderata. Il paziente riferisce che la puntura di spillo è meno acuta sul lato affetto, oppure non avverte senzazioni dolorose ma è consapevole di essere toccato. **2.** Ipoestesia grave. Il paziente non sente di essere toccato sul lato affetto	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐
9. Linguaggio Molte informazioni sulla comprensione si deducono dalle precedenti sezioni della scala. Al paziente viene chiesto di descrivere cio' che sta accadendo nella vignetta allegata, di denominare gli oggetti illustrati nella pagina allegata e di leggere l'elenco di frasi allegato. La comprensione verbale è valutata anche in base alle risposte ottenute nelle precedenti prove, incluso l'esame neurologico generale. Se un deficit visivo interferisce con i test, va chiesto al paziente di identificare gli oggetti che gli vengono posti nella mano, di ripetere e di pronunciare le parole. Al paziente intubato dovrebbe essere chiesto di scrivere una frase. Al paziente in coma (domanda 1a = 3) viene arbitrariamente assegnato il punteggio '3'. In caso di stupor o limitata collaborazione, l'esaminatore sceglierà il punteggio ricordando che '3' va assegnato solo se il soggetto e' muto e non esegue alcun ordine.	**0.** Normale **1.** Afasia da lieve a moderata. Nell'eloquio spontaneo, fluenza o comprensione sono un po' ridotte, ma le idee vengono espresse senza significative limitazioni. La conversazione sul materiale allegato può essere difficile o impossibile, ma le risposte del paziente consentono di identificare la figura o gli oggetti denominati. **2.** Afasia grave. L'espressione è frammentaria e l'ascoltatore è costretto a fare domande e a tentare di estrapolare i contenuti dalle risposte. La quantità di informazioni scambiata è modesta e la comunicazione è possibile solo grazie allo sforzo dell'ascoltatore. Le risposte del paziente non consentono di identificare la figura o gli oggetti denominati. **3.** Muto, afasia totale. Fluenza e comprensione totalmente inefficaci	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
10. Disartria Anche se si ritiene che il paziente non sia disartrico, l'eloquio va comunque valutato chiedendo di leggere o ripetere le parole dall'elenco allegato. In caso di afasia grave puo' essere valutata la chiarezza dell'articolazione del linguaggio spontaneo. Il punteggio 'NV' va assegnato solo ad un paziente intubato o con altri impedimenti fisici a pronunciare le parole. Occorre comunque fornire spiegazione scritta del perché di tale punteggio	**0.** Assente **1.** Disartria da lieve a moderata. Il paziente pronuncia male almeno alcune parole ma l'eloquio è comprensibile **2.** Disartria grave. L'articolazione della parola è talmente alterata da rendere l'eloquio incomprensibile, in assenza di afasia o in modo non spiegabile dall'entità dell'afasia. Il paziente può essere muto o anartrico. **NV.** Intubato o altro impedimento fisico all'articolazione della parola (spiegare)	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☒	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ NV ☐
11. Inattenzione L'inattenzione può essere identificata mediante i test precedenti. In caso di deficit visivo grave che non consente la stimolazione simultanea visiva doppia, se gli stimoli cutanei sono normali, il punteggio e' normale. Se il paziente e' afasico, ma mostra normale attenzione verso entrambi i lati, il punteggio e' normale. Il neglect visuo-spaziale e l'anosognosia vanno considerate come prova di inattenzione.	**0.** Assente **1.** Inattenzione visiva, tattile, uditiva, spaziale o corporea, oppure estinzione alla stimolazione bilaterale simultanea in una delle modalità sensoriali. **2.** Grave emi-inattenzione o estinzione a più di una modalità. Non riconosce la propria mano o si rivolge solo ad un lato dello spazio.	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐

iltuofisiatra.it

NIHSS versione italiana -
a cura del Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'